



Becherie

Psicopatología (Universidad Nacional de Córdoba)



Scan to open on Studocu

La constitución del concepto freudiano de psicosis

Por Paul Bercherie

Me propongo en este pequeño trabajo situar las condiciones en las cuales Freud pudo encontrar el problema clínico de las psicosis. Intentaré pues describir a grandes rasgos el estado de la cuestión en el momento en que Freud comienza sus investigaciones en ese campo, y los materiales clínicos y las orientaciones conceptuales que pudo tomar prestadas o que guiaron su mirada. Podemos medir de esta manera la originalidad específica del abordaje freudiano, como así también las filiaciones que lo vinculan con su arraigo histórico. Me basaré en los dos tomos de mis Fundamentos de la Clínica¹, que constituyen el telón de fondo de este artículo, y donde se puede encontrar un estudio más completo de los documentos sobre los cuales él se basa.

A. Posición del problema antes de Freud

1°) Me parece que el *Vocabulario de Psicoanálisis* de J. Laplanche y J. B. Pontalis expresa una opinión ampliamente difundida en el medio psicoanalítico que considera que hacia 1895-1900 Freud "encuentra en la cultura psiquiátrica de lengua alemana una distinción muy nítida desde el punto de vista clínico entre la psicosis y la neurosis". No obstante, ésta es una afirmación totalmente errónea: en efecto, los dos términos existen desde hace ya largo tiempo en el vocabulario nosológico (más de un siglo para el término de neurosis, y medio siglo para el de psicosis), son de empleo corriente, pero de ningún modo constituyen un par de opuestos, ya que provienen de dos planos conceptuales diferentes, de alguna manera perpendiculares el uno del otro. Esto es lo que explica que lejos de excluirse, por el contrario, muy fácilmente pueden superponerse; una misma entidad (por ejemplo la melancolía o la manía en la literatura psiquiátrica alemana de la época) puede ser a la vez una psicosis y una neurosis.

En efecto, el término psicosis significa entonces simplemente enfermedad mental, afección psiquiátrica: sustituye como concepto técnico al viejo término de locura, en la medida en que la evolución de las concepciones clínicas tendía a hacer de ella no ya un género, sino una clase, y a emplearla pues en plural (véase más adelante). Ninguna significación más precisa limita la extensión del término de psicosis, que recubre tanto los problemas mentales de origen orgánico ("psicosis parálitica" para la parálisis general por ejemplo), como las afecciones funcionales, los delirios propiamente dichos, o esas alteraciones mentales limitadas y controladas que hoy en día llamaríamos neurosis (cf. la "psicosis obsesiva" o las "psicosis histéricas" de los autores de la época).

En cuanto al término de neurosis, no designa una noción clínica como el de psicosis, sino un concepto etiológico y nosológico: afecciones funcionales del sistema nervioso, donde las perturbaciones más extendidas y escalonadas de sus funciones no reposan sobre ninguna lesión orgánica detectable. Aún

nos interrogamos si se trata de un cuadro provisorio condenado a desaparecer con el progreso de las técnicas histológicas (la enfermedad de Parkinson por ejemplo, quedará durante largo tiempo como una neurosis), o si podría verdaderamente tratarse de una clase de afección, con una real coherencia conceptual, que se caracterizaría por la benignidad desde el punto de vista del pronóstico y la fugacidad de sus síntomas, pero también por la permanencia de la enfermedad, es decir, su aspecto constitucional, manifestación de un terreno degenerativo, de una tara más o menos hereditaria. Las psicosis sin base orgánica objetivable que no se basan en una lesión cerebral o en un proceso tóxico-infeccioso, tienden de este modo a ser consideradas como neurosis, y eso bajo una doble perspectiva. En primer término, como afecciones autónomas, las neurosis de la zona del sistema nervioso que corresponde a los procesos jerárquicos más elevados, es decir, al psiquismo: son las *psiconeurosis*, enfermedades mentales funcionales a veces llamadas "psicosis propiamente dichas" (Maignan las opone a los "estados mixtos" entre la psiquiatría y la patología médica). Luego también las manifestaciones particulares extendidas a las funciones nerviosas superiores, es decir, mentales, las grandes neurosis generalizadas tal como la epilepsia, la histeria o la neurastenia, cuyos síntomas cubren el conjunto de las funciones nerviosas. En la nosología alemana entonces corriente, tal como la de Krafft-Ebing, se distingue pues: las perturbaciones mentales constantes, perturbaciones caracteriales y afectivas de las neurosis (*neuropsychosis*); los *accidentes mentales* que forman directamente parte de la neurosis, como las crisis psíquicas y los estados segundos histéricos; finalmente, las psicosis que nacen sobre el terreno de la neurosis pero que sólo difieren de las otras psicosis autónomas en algunos detalles (por ejemplo la paranoia histérica, donde son más frecuentes los temas erótico-místicos y los síntomas de persecución física).

La oposición conceptual neurosis-psicosis, es decir, el concepto de psicosis, es algo puramente freudiano, y seguirá siéndolo durante largo tiempo. Así, Pierre Janet puede parecer que converge con Freud, ya que en la misma época reconoce sólo dos neurosis, la histeria y la psicastenia (que recubren a *grosso modo* las perturbaciones fóbico-obsesivas), pero no tardará en considerar la melancolía, la manía, los delirios crónicos y la esquizofrenia, como neurosis en el mismo sentido etiopatológico que le da a ese término. Es pues en el mismo pensamiento freudiano que hay que comprender la génesis de este par de opuestos; veremos cómo. Intentaremos hacer el inventario de lo que Freud pudo realmente tomar de la clínica psiquiátrica de su tiempo.

2°) Como ya lo indiqué en diversas ocasiones, la clínica psiquiátrica sufre alrededor de mediados del siglo XIX una mutación que renueva totalmente su trayectoria. La primera clínica, aquélla que funda Pinel al mismo tiempo que hace autónoma la dimensión clínica como una ciencia de pura observación, metodológicamente separada de las hipótesis etiopatogénicas así como también de las consideraciones prácticas o terapéuticas, así pues la primera clínica consideraba a la locura como un género unitario, homogéneo, en el interior del cual las especies se separaban como cuadros sincrónicos, síndromes cuyo concepto se agrupa alrededor de la manifestación más central, más importante del estado mórbido. Así

de Pinel a Baillarger y Delasiauve, un análisis que se hace progresivamente más fino, opone los estados de excitación (manía), los estados de depresión (lipomanía), los estados delirantes (monomanía), los estados estuporosos (estupidez), los estados de incoherencia (demencia), los actos impulsivos (locura o monomanía instintiva). Estas formas se suceden, se asocian, se combinan; por otra parte, su etiología es inesperada y son pensadas más bien como tipos de reacciones psico-cerebrales más que como enfermedades en el sentido moderno, anátomo-clínico, que inauguró Bichat.

Sin embargo, una especie se aísla progresivamente de la locura así concebida: la idiotez representa un estado cuya patogenia y evolución están determinadas, y que se distingue clínicamente del resto. Pero sobre todo, desde 1822, el descubrimiento fortuito de la parálisis general Bayle, prepara el trastorno conceptual metodológico que encontrará su teórico en Falret. Esto es así ya que en la clínica sincrónica surgida de Pinel, la parálisis general se distingue como una entidad patológica que despliega en un ciclo diacrónico una secuencia de estados mórbidos que recubren el conjunto de síndromes pinealianos. El diagnóstico no se basa en la parte central del cuadro, sino en pequeños signos secundarios en apariencia, pero que son en realidad esenciales, muy finalmente analizados, que lo especifican y diferencian de todo otro cuadro parecido: la monomanía, la manía, la misma demencia, de la parálisis general no pueden ser confundidas con síndromes de ese tipo. Por lo demás, esta primera "forma natural" (Falret) presenta una patogenia particular y típica: la meningo-encefalitis que le es específica.

Serán necesarios treinta años para que se imponga esta revolución conceptual a través de la enseñanza de J. P. Falret que extrae de ello una crítica radical de la antigua metodología, y los principios para la construcción de una nueva clínica: Estudio de la evolución de la enfermedad, del pasado y el porvenir del enfermo, búsqueda de una patogenia específica, compilación de signos negativos, atención a los pequeños signos secundarios que permiten la diferenciación de entidades hasta entonces confundidas en los "conglomerados dispares" de la nosología de Pinel y de Esquirol. Al mismo tiempo, los lazos de la clínica y de la nosología, estrechamente complementarios desde Pinel (puesto que se trataba de hacer distinciones en un espectro homogéneo de fenómenos) se aflojan: la locura ya no es más un género sino que es una clase de enfermedades yuxtapuestas las unas a las otras, en eso que se llamará más tarde una clasificación-nomenclatura. Toda una serie de perturbaciones que desde hacía un tiempo tendían a aislarse como "vesanias sintomáticas" de las "vesanías puras", de la locura propiamente dicha (concepción de Baillarger), pueden responder a esta nueva óptica: perturbaciones mentales del alcoholismo, enfermedades infecciosas y lesiones cerebrales, locura epiléptica. J. P. Falret y sus discípulos comenzaron a describir otras nuevas: locura circular, delirio de persecución con evolución progresiva de Laségue, perseguidos-perseguidores (futuro delirio de reivindicación) y locura de duda con delirio del tacto (neurosis obsesiva) de Falret hijo, etc. Pero sobre todo Morel, el más importante de los discípulos de Falret, prosigue la enseñanza de su maestro agregándole su toque personal: es la etiología (la patogenia sería un término más exacto) la que le parece construir el gran principio que caracteriza a las nuevas "formas naturales". Para esta inmensa clase de enfermedades mentales sin causa orgánica

que Baillarger reagrupaba en las "vesanías puras", va a proponer un principio de comprensión y de clasificación: el estudio del terreno, la predisposición, comprendida en los términos de su tiempo como degeneración más o menos hereditaria.

Así se sientan las bases de la segunda clínica psiquiátrica, la "clínica de las enfermedades mentales", para retomar el título asignado a la cátedra de psiquiatría en las facultades francesas de medicina. Todo está listo para el medio siglo de observación y de discriminación que va a seguir: la noción de entidades clínico-evolutivas despliega una secuencia de cuadros clínicos en un ciclo típico, la oposición entre perturbaciones mentales adquiridas, de causa patológica específica, y las perturbaciones mentales constitucionales, que se arraigan en la predisposición de una personalidad defectuosa, apta para delirar (en sentido amplio) en situaciones vitales -dadas. Se puede decir que a partir de los años 1880, la escuela francesa integró ampliamente las nuevas orientaciones. Se trate del grupo de Magnan más próximo al de Morel, o del que alrededor de Séglas y de Ballet se relaciona más directamente con las de Falret padre e hijo, las descripciones clínicas corresponden a los criterios definidos más arriba, y la discusión se refiere más bien al reagrupamiento y la clasificación de las entidades así aisladas. Así las locuras degenerativas de Magnan reagrupan formas clínicas un poco dispares, pero dotadas cada una de ellas de una fuerte individualidad clínica y evolutiva; lo mismo para los "delirios sistematizados" de Séglas y Arnaud.

No se puede decir lo mismo de los autores alemanes prekraepelinianos. Si por un lado están muy fuertemente influenciados por Morel y retoman sus concepciones *doctrinales*, por otro lado, su clínica está todavía mucho más próxima de Griegsinger, es decir, de Esquirol, y siguen describiendo los síndromes de Baillarger y de Délasiauve. Desde luego, en muchos sentidos la obra del fundador de la clínica alemana, W. Griegsinger, constituye una fase intermedia, una obra bisagra histórica (1845) y conceptualmente entre las dos grandes fases de la evolución de la clínica psiquiátrica del siglo XIX. Griegsinger en efecto no concebía totalmente a la locura -a la manera de Pinel y de Esquirol- como un género unitario en el interior del cual se distinguen casos por el juego de comparaciones y oposiciones, sino como un gran ciclo, un proceso en el cual cada caso es una etapa en la degradación progresiva del espíritu que representa la enfermedad mental, "psicosis única". Así opone las formas primarias, donde el trastorno emocional es el factor esencial de la alteración mental (estados de depresión y de excitación), a las formas secundarias en la que está embotada, integrándose a la personalidad, al yo del sujeto, que deja debilitado, deformado, incluso disociado. Es entre esas formas secundarias que Griegsinger es de los primeros en distinguir el *delirio sistematizado* (*Verrücktheit*) aislando así (un poco después Guislain, un poco antes Baillarger) las psicosis delirantes (enfermedades de entendimiento), de las psicosis afectivas, distinción ausente en Pinel y Esquirol.

En lo esencial pues, se puede decir que los clínicos alemanes anteriores a 1900, habían permanecido sordos a las exhortaciones de Kahlbaum que intentaba retransmitirles lo esencial de la enseñanza de J.P.

Falret, en verdad con un estilo poco accesible. Sus notables descripciones de la hebefrenia, de la catatonía, de la heboidofrenia, su concepción restringida y precisa de lo que llama paranoia (delirio sistematizado crónico primitivo sin evolución del cuadro clínico, en particular hacia la demencia) tuvieron poco eco. Si la escuela alemana, con Krafft-Ebing, retoma el término de paranoia, es para hacerle designar el síndrome delirante, la monomanía intelectual de Baillarger, sin tener en cuenta la evolución, el terreno o la naturaleza particular del cuadro. De la misma manera, las locuras intermitentes reagrupan el conjunto de estados mórbidos de repetición, cualquiera sea su estructura clínica, y la noción de intermitencia tiene así más el valor de un criterio etiológico (terreno degenerativo) que no se integra - como en Falret o Magnan- a la descripción de una "forma natural".

Por el contrario, es la amplitud del esfuerzo de síntesis y de dominación teórica de los problemas psicopatológicos, lo que da la nota de originalidad a los trabajos alemanes desde Griesinger. Los autores alemanes son hombres de sistema: aspiran en el plano dogmático a la completud, y esta mira les confiere sin lugar a dudas una penetración bastante diferente a la de los autores franceses. Naturalmente, en ellos existe un armazón conceptual que encuadra la modalidad clínica, pero examinándola aparece bastante endeble, y el espíritu positivista permanece apremiante: ante todo es necesario describir, intentar señalar algunos rasgos generales al ras de la clínica, utilizar amplias opciones doctrinales bastante vagas que resuman la posición francesa y su desconfianza por los dogmas y los sistemas. Como dice Freud, los clínicos alemanes parten de "interpretar fisiológicamente el estado patológico y el nexo entre los síntomas (mientras que) al empujar a un segundo plano los puntos de vista fisiológicos, la observación clínica de los franceses gana en autonomía"². Por lo demás, este esfuerzo por una interpretación "fisiológica" de la clínica tiene todo su valor: de Griesinger a Bleuler y Jaspers, la psicopatología alemana produjo siempre análisis remarcables, incomparablemente más logrados que las bastante pobres tentativas de los autores franceses. Por ejemplo, es Krafft-Ebing quien por primera vez señala y describe la "constitución paranoica", retomada luego por el conjunto de los clínicos, quedando como una adquisición clínica irrefutable. Del mismo modo, lo que plantea Griesinger sobre la invasión de los fenómenos delirantes y la deformación subsiguiente del yo, va a constituir una de las bases de la conceptualización freudiana.

Finalmente será Kraepelin quien impondrá -con el cambio del siglo- la nueva clínica en Alemania, la que Freud reconocerá tardíamente por la mediación, por otra parte un poco deformante, de la escuela de Zúrich (Jung, Bleuler, Abraham). Kraepelin retoma de Kahlbaum el concepto de entidad mórbida clínico-evolutiva con una etio-patogenia específica, como así también el acento sobre la especificidad de los estados terminales, con la noción de que los signos particulares los, anuncian desde el comienzo del ciclo mórbido. Esta última noción está presente en los Falret pero sin una insistencia particular. Morel, por el contrario, la olvida puesto que describe una sola forma demencial terminal, y es eso lo que finalmente retendrán los autores franceses. En su tentativa de concluir con una nosología etiopatogénica, Kraepelin podrá basarse en el aislamiento ya clásico de las psicosis adquiridas con una causa somática evidente

(estados tóxico-infecciosos, demencias orgánicas), y de las formas "degenerativas", en las que la predisposición patológica de la personalidad está en el primer plano del trastorno mórbido (oligofrenias, trastornos neuróticos o psicopáticos). Para el resto, es decir, para lo que reservamos desde Freud el término de psicosis, va inspirarse ampliamente en Kahlbaum para oponer (en 1899):

- Los delirios crónicos sistematizados no alucinatorios en los que el cuadro clínico permanece estable, y la personalidad, la afectividad y el juicio se mantienen por otra parte intactos en todo lo que no concierne al dominio del delirio. Reserva el término de paranoia para la designación de esos casos, concebidos como constitucionales.
- Los estados agudos que evolucionan de manera periódica pero que dejan en su decrecimiento un psiquismo intacto, y en el que no se distingue un daño verdaderamente profundo de la personalidad en el curso del ataque. Se trata de la psicosis maníaco-depresiva.
- Los estados agudos o crónicos que evolucionan indefectiblemente hacia una forma particular de deterioración mental en la que la inteligencia, la memoria, la orientación témporo-espacial están intactas, se distingue entonces un daño profundo, primario, pero con una agravación progresiva de la afectividad, de la voluntad y de la atención (y luego del juicio) en el sentido de la indiferencia, de la apatía y de la disgregación de la personalidad.

En este último grupo bautizado primero como "procesos degenerativos" (1893) y luego como "procesos demenciales" (1896), Kraepelin reúne la hebefrenia y la catatonia de Kahlbaum en una forma delirante que posee un mismo proceso, que denomina "demencia paranoide". Pero en 1899, al rebautizar el grupo de la "demencia precoz", le agrega como segunda forma paranoide, toda la clase de las psicosis delirantes alucinatorias -llamadas hasta entonces "paranoias fantásticas"- que su concepción restringida y homogénea de la paranoia lo llevó a excluir.

3°) He aquí pues brevemente planteado en grandes líneas el decorado en el que se introduce Freud en el campo de la clínica psicopatológica. Sobre esta base, podremos examinar rápidamente algunos empréstitos conceptuales esenciales que operan sobre la clínica alemana de su época. Podemos agruparlos en dos subclases esenciales: conceptos nosológicos y modelos patogénicos. En el plano nosológico, el concepto clave alrededor del cual gira la mayor de las discusiones de la escuela alemana de fines del siglo XIX, es el de la Paranoia. Recubre el síndrome delirante considerado muy globalmente, puesto que si lo remitimos a las reglas metodológicas de Falret y Morel, se trata entonces de una entidad bastante mal delimitada clínicamente, etiológicamente, y en su evolución. Ella puede presentarse tanto como aguda como crónica, alucinatoria o sin alucinación, disociativa o dejando intacta la síntesis personal, primitiva o secundaria con una forma aguda (manía, melancolía, confusión mental), surgir en un terreno claramente predispuesto o ser una enfermedad adquirida en sujetos "de cerebro sano". Por otra parte, su delimitación plantea un problema en relación a los dos grupos clínicos:

- La neurosis obsesiva que algunos autores, siguiendo a Westphall, la consideran como una paranoia "abortiva", es decir, criticada, pues puede también analizarse como una invasión de la conciencia por neo-formaciones ideicas o alucinatorias. El mismo Krafft-Ebing dejará vacilar el síndrome obsesivo entre la neurastenia que constituía la base (véase más adelante) y la paranoia.
- La confusión mental, puesto que algunos autores consideran a la paranoia aguda como una forma de confusión onírica en la que la profusión delirante y alucinatoria lleva a un segundo plano clínico el encierro mental. Así Meynert incluye en su Amentia, en las partes de la forma estuporosa, una forma delirante que recubre tanto el onirismo como las psicosis delirantes agudas, cuya noción Freud utilizará.

Otro gran empréstito freudiano consiste en un modelo patogénico retomado de Morel por la clínica alemana de la época, particularmente de Krafft-Ebing. Lo evoqué anteriormente a propósito del concepto de neurosis: es la idea de un estado neurótico basal, en el sentido de perturbación funcional difusa del sistema nervioso - tanto local como central- que preexistirá a la eclosión por la acción de diversas causas, perturbaciones mentales constitucionales en los que ninguna patogenia orgánica es objetivable o verosímil. Tanto la epilepsia como la histeria sirven aquí como modelos de una concepción más amplia, en la que Freud retomará lo esencial en su gran oposición neurosis actuales-neuropsicosis. En todo caso es totalmente corriente en esta época considerar todos los síntomas fóbico-obsesivos como injertos de la neurastenia, síndrome de "debilitamiento irritable" del sistema nervioso, o el establecer un lazo entre la hipocondría-neurosis y la paranoia.

Por otra parte, Freud estará muy influenciado por la concepción de Griegsinger, es decir, por la idea de que las manifestaciones psicopatológicas se reparten en dos grupos bastante distintos; el primero (formas primarias) corresponde al proceso mórbido y es el testimonio de la invasión que padece una personalidad que lucha todavía contra los fenómenos sintomáticos; el segundo (formas secundarias) es el resultado de una suerte de adaptación terminal al nuevo mundo y al nuevo yo que creó la enfermedad: es el trabajo de compromiso, de la asimilación de elementos delirantes, de la sumisión al proceso mórbido, y a veces de la desintegración final de la personalidad. Veremos hasta qué punto.

Freud³ en la segunda fase de su trabajo sobre las psicosis, estuvo impresionado por el modelo propuesto por Griesinger, el de la *psicosis única*.

B. Freud la psicosis de defensa: 1894 – 1896

1) La investigación freudiana – incluyendo también el problema de la psicosis como lo veremos más adelante – toma su punto de partida en los problemas clínicos que plantea la histeria. En otro lugar mostré

cómo el trabajo semiológico ejemplar de Charcot – alrededor de 1895 – llega a la paradoja en la que se origina el psicoanálisis: indudablemente los síntomas histéricos se presentan con toda la objetividad y la materialidad de los signos clínicos de las enfermedades orgánicas, en particular neurológicas; no obstante, no son más que la expresión de un trastorno de la esfera mental, la realización funcional de una idea de impotencia motriz, de insensibilidad, o de una representación perceptiva o motriz. Este descubrimiento hace caer la metáfora nerviosa que dominaba la comprensión de la histeria desde hacía dos siglos; él deriva de la confrontación entre la histeria y la hipnosis con sus manifestaciones sugestivas, como así también del progreso de la semiología neurológica que demuestra progresivamente el carácter no-orgánico de la sintomatología pseudo-neurológica de la “gran neurosis”.

De golpe Freud capta la importancia del problema y sus dos vertientes; contribuye por su parte a la discusión semiológica, que despeja en sus tres primeros párrafos de su artículo “Algunas consideraciones para un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas”, en el que concibe el proyecto – a partir de su encuentro con Charcot – que escribirá en 1888. Hay que subrayar también que si toda la sintomatología física de la histeria aparece como la manifestación de un trastorno mental, la propia situación de los accidentes mentales de la neurosis va a encontrarse bastante desnivelada. En efecto, no olvidemos que la histeria, entre las diversas formas de crisis que puede provocar, incluye también las manifestaciones alucinatorias, los estados segundos y crepusculares, los delirios amnésicos, los fenómenos de personalidades alternantes, que constituyen las legítimas psicosis histéricas, que jamás nadie pensó en eliminarlas de la neurosis. Aunque se trate de trastornos agudos, en general de duración bastante breve, el término de psicosis convenía a su designación simplemente descriptiva, puesto que se trata precisamente de trastornos mentales manifiestos.

He aquí pues que la histeria propone el modelo de una noble modalidad de manifestaciones psicopatológicas: los síntomas neuróticos con una expresión pseudo-física y los síntomas psicóticos en los que el carácter mental es por el contrario patente. Este es el verdadero origen del par conceptual neurosis – psicosis en el pensamiento freudiano, que veremos cómo cobra un sentido bastante particular. A partir de la “Comunicación preliminar” de Breuer y Freud en 1893, se pone en evidencia la disparidad estructural de los dos grupos de síntomas. Recordemos rápidamente que ellos consideran que la “escisión de la conciencia...existe de manera rudimentaria en toda histeria; entonces, la inclinación a disociar...sería el fenómeno básico de esta neurosis” (“Estudios sobre la histeria”, tomo 11, pág. 37). A partir de la constitución de este grupo psíquico, separado del resto del psiquismo y de la conciencia que constituye el recuerdo activo del o de los traumas patógenos, se pueden distinguir dos situaciones:

- “el síntoma histérico permanente corresponde a una penetración de ese estado segundo en la inervación corporal gobernada de ordinario por la conciencia normal” (idem, pág. 41).
- “un ataque histérico atestigua una organización más alta de ese estado segundo...se apodera...de la inervación corporal y de la existencialidad del enfermo” (idem). En ese estado “son alienados, como todos nosotros lo somos en el sueño” (pág. 39).

Desde esta época, y es lo que lo va a oponer progresivamente a Breuer, Freud considera la constitución

del grupo psíquico disociado de la conciencia como “la consecuencia de un acto voluntario del enfermo...cuyo motivo es posible indicar” (“Las neuropsicosis de defensa”, tomo III, pág. 48). Esta es la teoría de la defensa que surge al abandonar la hipnosis y la experiencia de la resistencia del paciente a la rememoración curativa. En este marco, la doble sintomatología de la histeria aparece con mayor claridad basándose en una disparidad de estructura:

- la defensa del yo consiste en separar el afecto, el quantum de excitación ligado a la representación traumática, lo que le permite hacerla desaparecer de la conciencia. Esta suma de excitación tiene diversos destinos que varían siguiendo las modalidades defensivas; en la histeria se trata de la conversión en una invasión corporal, lo que genera los síntomas físicos neuróticos. El yo controla la situación, puesto que el esfuerzo de la defensa fue un éxito.

- pero el yo corre también un peligro, el “de ser vencido, sucumbir a la psicosis” (“Estudios sobre la histeria”). Este es el fracaso de la defensa que se encuentra frente a la invasión del yo por la representación traumática, es decir, mecanismos de ataques o psicosis histéricas; cuyo modelo fisiológico en el sueño, o más bien, la pesadilla.

Tal es pues la primera fuente de la concepción freudiana de la psicosis y de oposición neurosis – psicosis: la neurosis corresponde a un éxito de la defensa, a una dominación del yo del material reprimido y a la formación de sustitutos sintomáticos deformados; la psicosis es el resultado del fracaso de la defensa, de la invasión y de la subyugación del yo por las representaciones patógenas traumáticas. A partir de esta época, Freud dispone de nociones más diversificadas y de un material más variado, durante un largo período utiliza este modelo explicativo hasta que domina finalmente su concepción de la psicosis. Por otra parte, hay que indicar que la referencia al sueño a partir de 1892 – antes de cualquier descubrimiento de Freud en ese campo – apunta al origen de una tal concepción, al modelo conceptual del psiquismo que lo encuadra. Se trata de la teoría psicológica espiritualista surgida de Maine de Brain, que Baillarger impuso en psicopatología bajo el nombre de teoría del Automatismo; ya lo describí detalladamente en otro lugar.

2) Pero al mismo tiempo, la concepción de la defensa le posibilitará a Freud ampliar el campo psicopatológico: el análisis de la neurosis obsesiva, como así también el de las formas de la psicosis de defensa, la “confusión alucinatoria y la paranoia. En la tercera parte de su artículo sobre la neuropsicosis de defensa (1894), Freud examina un caso que diagnostica como confusión alucinatoria o Amentia de Meynert. A decir verdad, la nosología de esta época no dejaba muchas otras posibilidades más que la de asimilar este género de síndromes a un onirismo y al grupo de la confusión mental (Amentia). De hecho se trata de ese tipo de arrebatos delirantes que la escuela de Cluade llamará entre las dos guerras “delirio de ensueño” o esquizomanía. El sujeto se confina ahí en una realización imaginaria autística de deseos a los cuales la realidad les presentó una objeción más o menos brutal; la pérdida del objeto, como en el caso de Freud, es un ejemplo privilegiado. Es difícil verificar el grado de objetivación de los escenarios imaginativos de esos sujetos, pero probablemente no alcanza el realismo alucinatorio de los estados oníricos.

Freud remarca pues que “existe una modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa, que consiste en que el yo desestima (verwerfen) la representación insoportable junto con su afecto y se comporta como si

la representación nunca hubiera comparecido. Sólo que en el momento en que se ha conseguido esto, la persona se encuentra en una psicosis...” (“Las neuropsicosis de defensa”, pág. 59). A la inversa de la psicosis histérica, la “confusión alucinatoria” es el resultado de una maniobra defensiva lograda. Freud utiliza aquí la otra cara, esta vez positiva, del modelo onírico: el sueño feliz, el cumplimiento omnipotente del deseo. Por otra parte, es evidente que la representación traumática en cuestión esta vez no es de una naturaleza idéntica a la de los otros casos de neurosis de defensa: no se trata de una moción sexual sino de una realidad dolorosa. Freud lo distingue bastante bien: “el yo se arranca de la representación insoportable, pero *esta se entrama de manera inseparable con un fragmento de la realidad objetiva*, y en tanto el yo lleva a cabo esta operación, se deshace también, total o parcialmente, de la realidad objetiva” (ídem, pág. 60, el subrayado es mío).

Serán necesarios quince años para que Freud pueda sacar partido en el plano teórico de este contraste, treinta⁴ para que defina claramente las coordenadas: el modelo psicológico asociacionista que utiliza en 1894 le impide la diferenciación del estatuto de las dos representaciones. Desde luego será necesaria una gran revisión para que los registros del funcionamiento subjetivo y de la actividad del yo (teoría del narcisismo, segunda tópica) adquieran un lugar en la teoría y devuelvan a la clínica ese tipo de oposiciones.

En el manuscrito contemporáneo que dirige a Fliess, el manuscrito H de enero de 1895, Freud extiende sus análisis a un caso de paranoia⁵. Los símbolos delirantes (ideas de referencia, de vigilancia, comentarios peyorativos) aparecen ahí como el sustituto de un reproche interior inconsciente concerniente a un recuerdo erótico reprimido. Freud indica: “Muy simple: se trata del abuso de un mecanismo psíquico utilizado con harta frecuencia dentro de lo normal, el traslado o proyección. Ante cada alteración interior, tenemos la opción de suponer una causa interna o una externa. Si algo nos esfuerza a apartarnos del origen interno, naturalmente recurrimos al origen externo. En segundo lugar, estamos habituados (por la expresión de las emociones) a que nuestros estados interiores se denuncien antes los otros. Esto da por resultado el delirio normal de ser notado, y la proyección normal. Y normal es, en efecto, mientras a todo esto permanezcamos concientes de nuestra propia alteración interior. Si la olvidamos, nos queda sólo la rama del silogismo que lleva hacia afuera, y de ahí la paranoia, con la sobrestimación de lo que de nosotros se sabe y de los hechizos que padecemos. Y eso que se sabe de nosotros, y que nosotros no sabemos, no podemos admitirlo. Por tanto, abuso del mecanismo de proyección a los fines de la defensa” (Fragmentos de la correspondencia con Fliess, tomo 1, pág. 249).

Se pregunta a continuación: “¿rige esta concepción también para otros casos de paranoia? Yo opinaría que para todos...El paranoico litigante no se concilia con la idea de haber obrado mal, o de tener que separarse de sus bienes. En consecuencia, el juicio no es conforme a derecho, él no ha obrado mal, etc....La gran nación no puede entender la idea de haber sido derrotada en la guerra. Por consiguiente, no ha sido derrotada, la victoria no vale; así da el ejemplo de una paranoia de masas, e inventa el delirio de una traición...El funcionario relegado en los ascensos necesita (imaginar) el complot de persecución y que es espiado en su oficina, de lo contrario tendría que confesarse su fracaso...Pero lo que así se genera no

es siempre forzosamente un delirio de persecución. Un delirio de grandeza consigue, quizás todavía mejor, mantener apartado del yo lo penoso. Es el caso de la marchita cocinera que debería hacerse a la idea de permanecer excluida de la dicha amorosa. Es el momento justo para el caballero de la casa frontera, quien a todas luces quiere desposarla y se lo da a entender de una manera tan asombrosamente tímida, aunque perceptible” (ídem, pág. 250).

En este estado de su investigación, Freud dispone de tres modelos psicopatológicos para pensar el problema de la psicosis⁶:

- la psicosis de subyugación del yo que corresponde a un fracaso de la defensa y a una invasión de la conciencia por lo reprimido victorioso. Es del tipo de la pesadilla y de las psicosis histéricas. Con respecto a esto, distingue en el manuscrito H que “las alucinaciones son hostiles del yo” (pág. 251) puesto que manifiesta el embargo de lo reprimido.

- las dos formas de psicosis de defensa: el delirio proyectivo paranoico y la realización alucinatoria de deseo que opone contrario a la representación dolorosa una representación contraria (Amentia, megalomanía). El carácter común de la defensa lograda le permite a Freud aproximarlas, pues al fin de cuentas, “la idea delirante es o bien el calco o bien lo opuesto de la representación que cayó bajo la defensa (delirio de grandeza). Paranoia y confusión alucinatoria son las dos psicosis de “desafío eso” o de “justamente es eso”. La “referencia a sí propio” de la paranoia es análoga a las alucinaciones de la confusión, que justamente quieren aseverar lo contrario del hecho que cayó bajo la defensa. Así, la referencia a sí propio quiere demostrar siempre que la proyección es correcta” (ídem, pág. 251).

Ese carácter de negación delirante y de satisfacción yoica del deseo le brinda a Freud por otra parte, una irrefutable intuición de la estructura narcisística de la psicosis. Así afirma: “en todos los casos, la idea delirante es sustentada con la misma energía con que el yo se defiende de alguna otra idea penosa insoportable. Así, pues, atan al delirio como a sí mismos. He ahí el secreto” (ídem, pág. 250 – 251). El modelo asociacionista del psiquismo que domina todavía en esta época el pensamiento freudiano impedirá la clara aprehensión conceptual de esta primera intuición clínica.

Primeramente debemos subrayar que el concepto bastante flexible de defensa, es el que le permite a Freud disponer de un espectro bastante amplio de mecanismos psicopatológicos y de una nosología abierta. Por lo demás, si su penetración remarcable de la psicología de las neuropsicosis lo separa definitivamente desde esta época de su contexto histórico, comenzando la estructuración del psicoanálisis como campo autónomo del saber, el conjunto de sus adquisiciones clínicas se inscriben en el registro: causa, origen, significación y mecanismo del síntoma. Es parte de las mismas condiciones epistemológicas de la apertura freudiana, que su paso lo oriente primeramente hacia la investigación de los síntomas más que a la enfermedad, es decir, de la estructura, intenté demostrarlo en otra parte. En última instancia, para la determinación de lo que prontamente se llamará la “elección de neurosis”, en el caso de la defensa, Freud reconoce que se trata todavía de “un proceso...(que) escapa...al análisis psicológico-clínico. Corresponde verlo como expresión de una predisposición patológico-clínico. Corresponde verlo como expresión de una predisposición patológica de grado más amplio” (a propósito del caso de Amentia en

“Las neuropsicosis de defensa”, pág. 60). En efecto, aquí se reenvía a la constitución particular del enfermo, y luego a una teoría etiopatogénica que se inscribe en la tradición de Morel entonces pregnante en todas las escuelas clínicas europeas.

3) Algunos meses después de estos primeros trabajos, Freud se pone a escribir el “Proyecto para una psicología científica” (otoño de 1895). Se basa en un nuevo paso en la investigación clínica de la histeria, en la que la teoría de la seducción representa la constante doctrinal, que no es nada menos que el primer encuentro de Freud con la sexualidad infantil. Sobre esta base, Freud le envía a Fliess el 1º de enero de 1896 el manuscrito K que titula “Cuento de Navidad”, cuyos materiales son retomados en las “Nuevas puntualizaciones acerca de las Neuropsicosis de defensa” (igualmente en 1896). La nueva óptica representa en una cierta manera la aceptación del argumento de Breuer, que no podía imaginar que un esfuerzo actual de la defensa pueda crear el clivaje histérico; Freud encuentra entonces en la idea del efecto de retroacción de un traumatismo precoz, la llave de la represión originaria, condición previa a toda defensa patológica interior.

Correlativamente, el concepto de defensa va progresivamente desapareciendo durante treinta años del pensamiento freudiano, porque la represión es de ahora en adelante el *primum movens*, el tronco común obligado del proceso neurótico, sea cual fuere la salida final. En el lugar de la concepción primitiva en la que la defensa y la formación de síntoma formaban un solo y mismo movimiento, Freud va a desprender de la neurosis obsesiva un nuevo modelo mucho más complejo. Distingue cuatro periodos:

- Primer periodo, de la “inmoralidad infantil”, en el que se producen los acontecimientos que devendrán retroactivamente traumáticos y que constituyen el mudo de la represión originaria.
- Segundo periodo, aparición de la madurez sexual, investimento sexual de escenas infantiles y represión.
- En su lugar aparece un síntoma primario de defensa que Freud llamará más tarde formación reactiva y que es la negación exacta de lo reprimido. En la neurosis obsesiva en la que se trata de una escena (secundaria) de seducción activa y del reproche interior que está ligada a ella, es el matiz de escrupulosidad, de vergüenza, de desconfianza de sí que marca este tercer periodo de “salud aparente”.
- Cuarto periodo, en la que estalla la enfermedad propiamente dicha por el fracaso de la defensa y el retorno de lo reprimido (en particular por la acción de perturbaciones sexuales actuales). El reproche reaparece entonces bajo una forma deformada, ya sea desplazado sobre representaciones neutras obsesionantes, o ya sea bajo la forma de un afecto doloroso obsesionante. En este estadio, se entabla una lucha entre esas formaciones de compromiso y la defensa secundaria (rumiaciones, locura de duda, ceremonias, fobias diversas, compulsiones) que el yo les opone y que será rápidamente infiltrada por lo reprimido, de ahí su carácter compulsivo. A veces, el yo agotado es vencido por los síntomas, obteniendo de este modo la creencia en el

reproche, lo que da su lugar a episodios de delirios melancólicos (síntomas de dominación del yo).

Este remarcable análisis va a permanecer como el modelo de la descripción de un proceso neurótico en el conjunto de la obra de Freud. Remarquemos que éste conduce a una diferenciación jerárquica de cuatro grupos de síntomas que permite por otra parte, la distinción de varias formas clínicas de neurosis obsesivas siguiendo la preeminencia de uno u otro tipo sintomático. Pero este modelo, que inmediatamente Freud intenta aplicarlo a la paranoia, va a tener un efecto muy particular en su teoría de las psicosis, ligada todavía a la concepción de una frase primaria común de represión.

En efecto, Freud puede despejar una estratificación sintomática homóloga de las manifestaciones clínicas paranoicas:

- después de la primera fase en la que tienen lugar las escenas traumáticas, la represión de la primera fase se hace por vía de la proyección “puesto que se erige el síntoma (primario) defensivo de la desconfianza hacia los otros” (“Nuevas puntualizaciones...”, tomo III, pág. 183).
- las formaciones de compromiso de retorno de lo reprimido consisten en impresiones delirantes de observación, en voces y en alucinaciones visuales y sensitivas. Debemos subrayar que si las terceras a Freud le parecen “más cerca del carácter de la histeria” (ídem, pág. 183), las segundas, en las que “los reproches reprimidos retornan como unos pensamientos enunciados en voz alta” (ídem, pág. 184), le parecen funcionar “de hecho como en las obsesiones” (Manuscrito K, pág. 266, en las Correspondencia de Freud con Fliess).
- en lugar de la defensa secundaria de la neurosis obsesiva, asistimos a la “formación delirante combinatoria, el delirio de interpretación, que desemboca en la alteración del yo” (“Nuevas puntualizaciones...”, pág. 184). Es un trabajo de asimilación de los síntomas puesto que el modo particular de la defensa primaria (proyección) hace que ellos encuentren crédito cerca del yo, es lo que Freud considera “como expresión del avasallamiento. El proceso halla su cierre en una melancolía (pequeñez del yo), que secundariamente presta a las desfiguraciones aquella creencia que se denegó al reproche primario, o bien, de manera más frecuente y seria, en una formación delirante protectora (delirio de grandeza), hasta que el yo es remodelado por completo” (Manuscrito K, pág. 267).

Vemos como la flexibilidad y la complejidad del nuevo modelo de desarrollo de un proceso neurótico le permite dar a Freud un paso muy original en relación a su misma metodología en el campo de las neurosis propiamente dichas. En efecto, podemos constatar que los diversos mecanismos psicóticos que pudo aislar se encuentran en este momento integrados a las etapas de un proceso único, al lado de los otros de descripción inédita:

- así el síntoma primario de defensa y el primer grupo de formaciones de compromiso (impresiones de observación y de vigilancia) corresponden al mecanismo propiamente paranoico descrito en 1895.
- los otros dos grupos de síntomas de retorno de lo reprimido recubren uno, las formaciones alucinatorias del tipo “psicosis histéricas”, y el otro, las voces que Freud, como lo hemos visto, relaciona con las

obsesiones.

- la defensa secundaria integra entre sus diversas formas la megalomanía, es decir, el delirio de realización del deseo.

El material restringido que dispone todavía Freud, no le permite ir más lejos en esta vía, que va a quedar como el modelo definitivo de la aprehensión freudiana de las psicosis, como lo podremos verificar con el examen de los trabajos del segundo gran período de su estudio clínico, el de los años 1910 – 1915. Así, la “demencia” autística esquizofrénica, concepto que Freud toma prestado de Jung y de Bleuler, se verá integrada al gran ciclo psicótico.

Por otro parte, podemos remarcar que el análisis “psicológico-clínico” al que Freud se dedica aquí, le permite diferenciar estructuralmente los mecanismos psicopatológicos que la clínica psiquiátrica (descriptiva) de su tiempo no distingue todavía: la especificidad del estatuto de las voces, las alucinaciones sensoriales y sensitivas, las “impresiones delirantes” (de observación, de vigilancia, de comentario), las fantasías de autosatisfacción (Amentia, megalomanía) y la disgregación autística esquizofrénica, etc. Por eso podemos pensar que la clínica francesa, mucha más puntillista y diferenciadora que la clínica alemana, le hubiera podido suministrar un soporte mejor adaptado a su investigación metapsicológica: así concluirá entre las dos guerras con la descripción de entidades nosológicas autónomas correspondientes entre otros a cada uno de los cinco mecanismos freudianos que acabo de enumerar, y que pueden estructurar de manera aislada una forma clínica (respectivamente la psicosis alucinatoria crónica, los estados oniroides, el delirio interpretativo, las parafrenias imaginativas, el síndrome hebefrénico).

En suma, el total de los primeros textos freudianos sobre la psicosis nos permitirá esclarecer las condiciones de constitución de los principales ejes conceptuales que le permitirán a Freud balisar el campo. Podemos oponer así primeramente su concepción de las neurosis, en las que el tronco común del mecanismo inicial desemboca en una pluralidad de transformaciones ulteriores⁷, y su teoría de las psicosis, que forman una u otra etapa de un gran ciclo único, el que evoca inmediatamente, hasta en la literalidad del concepto de deformación final del yo, las ideas de Griesinger. Si queremos desprender una nosología freudiana de las psicosis, será necesario buscarla en los elementos articulados del ciclo de la psicosis.

Esta es después la idea de una subyugación, de una dominación del yo como esencia del proceso psicótico⁸. Si Freud cesa durante diez años –con el abandono de la teoría de la seducción- sus investigaciones de las psicosis, encontramos de hecho el rastro de que una tal orientación continúa dominando su pensamiento en diversos pasajes de la correspondencia con Fliess (véase por ejemplo el comienzo de la carta del 11 de enero de 1897), así también como en el capítulo metapsicológico (cap. VII) de “La interpretación de los sueños”: “Menos inofensiva es la situación cuando el desplazamiento de fuerzas no es producido por la relajación nocturna del gasto de fuerzas de la censura crítica, sino por un debilitamiento patológico de ésta o por un refuerzo patológico de las excitaciones inconcientes, mientras el preconciente está investido y las puertas a la motilidad están abiertas. En tales casos, el guardián es yugulado, las excitaciones inconcientes someten al Prcc., y desde ahí gobiernan nuestra habla y nuestra

acción o fuerzan la regresión alucinatoria...A este estado lo llamamos psicosis" (pág. 599 – 560).

Finalmente, desde 1899, Freud le escribe a Fliess que él "fue llevado a considerar a la paranoia como el empuje de una corriente autoerótica" (carta del 9 de diciembre), reencontrando así la intuición de 1894 (véase el caso de la Amentia), lo que llevará diez años más tarde a la teoría del narcisismo. Es sobre estas tres ideas fundamentales, presentes desde los primeros pasos de las investigaciones freudianas, que se constituirá de aquí en adelante la teoría de las psicosis: unidad fundamental del ciclo psicótico, predominio del mecanismo de fracaso de la defensa y de la subyugación del yo, aspecto narcisístico-autoerótico de la regresión psicótica. Podemos subrayar la profunda coherencia interna de esta concepción: la psicosis representa el reverso del funcionamiento mental "normal", de ahí los modelos predominantes del sueño de la "psicosis única" de Griesinger⁹. En efecto, la experiencia inicial en la que se origina el concepto freudiano de psicosis, el de la histeria y su bipolaridad sintomática, continúa estructurando en profundidad la aprehensión teórica de todo el campo psicótico. Sin duda, es en este nivel que hay que situar las dificultades y los obstáculos del funcionamiento ulterior del modelo freudiano así despejado.

¹ *Los fundamentos de la clínica*, Ed. Manantial, Bs. As., 1986. *Genese des concepts freudiens*, Navarin/Seuil, París, 1983.

² Freud, S.; *Obras completas*: "Prólogo a la traducción de las Lecons du mardi de la Salpêtrière de Charcot" (1892); Ed. Amorrortu, tomo I, pág. 169. Todas las referencias de los textos freudianos en español, pertenecen a la misma editorial.

³ E. Harns nos enseña que su ejemplar del Tratado de Griesinger estaba "cuidadosamente subrayado con lápiz...De mayor interés es la acumulación de bosquejos en las páginas en las que Griesinger presenta su teoría del ego y su concepción de la metamorfosis (delirante) del ego". Véase E. Hans: "A fragments of Freud's library", *Psychanalytic Quarterly*, 1971, pág. 491.

⁴ Véase la reanudación del mismo caso en *Neurosis y Psicosis* (1924) Sin que ningún hecho clínico nuevo sea allí agregado.

⁵ En el sentido de Krafft-Ebing; se trata de una forma de delirio de relación sensitivo con evolución por arrebatos agudos.

⁶ Se trata de psicosis delirantes: Freud no se interesa todavía por los estados maníacos-depresivos, ya que los considera por otra parte como neurosis actuales (Véase el Manuscrito G del 7 de enero de 1895).

⁷ Así, la existencia de un "nudo histérico" en la neurosis obsesiva jamás le sugirió la idea de hacerla una entidad única con varios estratos.

⁸ La mayoría de las modalidades sintomáticas descritas en los textos de 1896 corresponden por otra parte a esta concepción.

⁹ Es decir, también de la teoría del automatismo que estructura una concepción bipolar de funcionamiento mental (sueño-vigilia o proceso primario-proceso secundario).